

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université Saleh Bounider
Faculté de médecine
3^{ème} année médecine

Malassezia et malassezioses

Dr. LETLOUT. M
Maître assistante en parasitologie- mycologie

Année universitaire : 2024/2025

1. Introduction

Les infections à *Malassezia*, appelées **Malassezioses** sont le plus souvent des **épidermomycoses**. Elles sont fréquentes et cosmopolites, généralement bénignes et récidivantes.

Elles sont dues à des **levures lipophiles**, kératinophiles, appartenant au genre *Malassezia*. Ces levures font partie de la **flore commensale cutanée** de l'homme et de certains animaux.

Chez l'homme elles sont responsables de : Pityriasis versicolor, dermite séborrhéique, pityriasis capitis, folliculites et plus rarement Infections systémiques.

2. Épidémiologie

2.1. Classification

- **Règne** : Fungi (champignons)
- **Embranchement** : Deutéromycotina
- **Classe** : Blastomycète (levures asexuées)
- **Famille** : Cryptococcaceae
- **Genre** : *Malassezia*

Plusieurs espèces sont impliquées en pathologie humaine : *Malassezia furfur*, *M. globosa*, *M. sympodialis*, et *M. restricta*.

2.2. Morphologie et Biologie

Malassezia est une **levure** de petites tailles (2 à 8 µm), ronde ou ovale, avec un bourgeonnement unipolaire.

Elles sont **saprophytes** de la peau humaine et sont abondantes sur les régions du corps où la peau est grasse, riche en glandes sébacées (thorax, visage, cuir chevelu, racine des membres et oreille).

Ces levures lipophiles, lorsqu'elles sont **abondantes** et en présence de **facteurs favorisants**, sont à l'origine de mycoses. Cela correspond au passage de la levure d'un état commensal à l'état parasitaire.

2.3. Facteurs Favorisants :

Les *Malassezia* prolifèrent sous l'influence de différents facteurs favorisants:

- L'hypersécrétion sébacée (peau grasse)
- Application de corps gras sur la peau
- L'hypersécrétion sudorale (transpiration)
- Chaleur, humidité
- Hypercorticisme
- L'immunodépression

3. Clinique

3.1. Pityriasis versicolor

Le Pityriasis Versicolor est une **épidermomycose** très répandue, bénigne, **récurrente et** non contagieuse. Elle est causée par l'invasion des couches les plus externes de la peau par des levures du genre *Malassezia*.

Les lésions apparaissent généralement sur le **tronc**, les **membres supérieurs** et le **cou**, épargnant le plus souvent le visage et les mains.

Formes typiques : Les lésions sont constituées par des macules arrondies ou ovalaires finement squameuses, non érythémateuses, non prurigineuses, bien délimitées et extensives, de couleur chamois à brune.

Formes achromiantes : Lésions peu squameuses et totalement dépigmentées

3.2. Dermite séborrhéique

C'est une affection cutanée courante, particulièrement chez l'adulte de sexe masculin.

Elle est favorisée par le stress et l'immunodépression et exacerbée en hiver.

Elle se caractérise par des lésions **érythémato-squameuses** qui peuvent avoir un aspect gras. Ces lésions se localisent préférentiellement sur les zones riches en glandes sébacées comme les **plis nasogéniens**, les sourcils, la lisière du cuir chevelu et le pavillon de l'oreille.

- **Chez le nourrisson :** il s'agit de plaques érythémateuses recouvertes de squames épaisses, grasses et jaunâtres sur le cuir chevelu (2ème et 3ème mois).

L'atteinte du cuir chevelu peut être associée ou non à une dermite du siège (bipolaire) et une atteinte des plis axillaires.

3.3. **Pityriasis capitis**

Caractérisé par une desquamation fine et non inflammatoire du cuir chevelu, peu prurigineuse, génératrice de nombreuses pellicules librement adhérentes et grasses, limitées au cuir chevelu. Il est favorisé par le stress et la séborrhée.

3.4. **Folliculite**

Il s'agit de lésions folliculaires pustuleuses, papuleuses, inflammation périfolliculaire. Le prurit est plus ou moins prononcé et constitue le principal signe clinique. Le siège habituel est le dos et les épaules.

3.5. **Infections systémiques :**

Ces infections surviennent sur terrain particulier : prématurés, immunodéprimés (nutrition parentérale riche en lipides +++).

4. **Diagnostic**

4.1. **Prélèvement**

- **Lampe de Wood** : les lésions présentent une fluorescence jaune-vert pâle.
- **prélèvement des squames.**
- **Scotch-test cutané** : C'est le meilleur moyen de prélèvement dans le Pityriasis versicolor.

4.2. **Examen Direct**

On observe, dans les squames, des amas de spores rondes à ovales, très réfringentes, à paroi épaisse, groupées donnant un aspect en « grappe de raisin ». On peut trouver également des **pseudo-filaments**.

Cet aspect caractéristique suffit pour poser le diagnostic d'affection de pityriasis versicolor.

4.3. **Mise en culture**

La culture est réalisée sur milieu Sabouraud-Chloramphenicol-Actidione + huile d'olive, milieu Dixon...

Les colonies obtenues ont un aspect granuleux et une couleur crème. Il est important de noter que la culture de cette levure est difficile à obtenir et rarement réalisée en pratique courante.

5. Traitement

- **Lésions peu étendues** : Traitement topique à base d'azolé en lotion, gel émulsion ou crème. EX: kétoconazole en topique (Ketoderm, gel moussant à 2%). Une 2ème application est recommandée 1 à 2 semaines après.
- **Lésions étendues ou rebelles au traitement local** : Azolés actifs par voie orale comme Itraconazole.
- Le traitement arrête l'infection fongique, mais les taches blanches persistent jusqu'à une exposition au soleil.